



SANTE PUBLIQUE

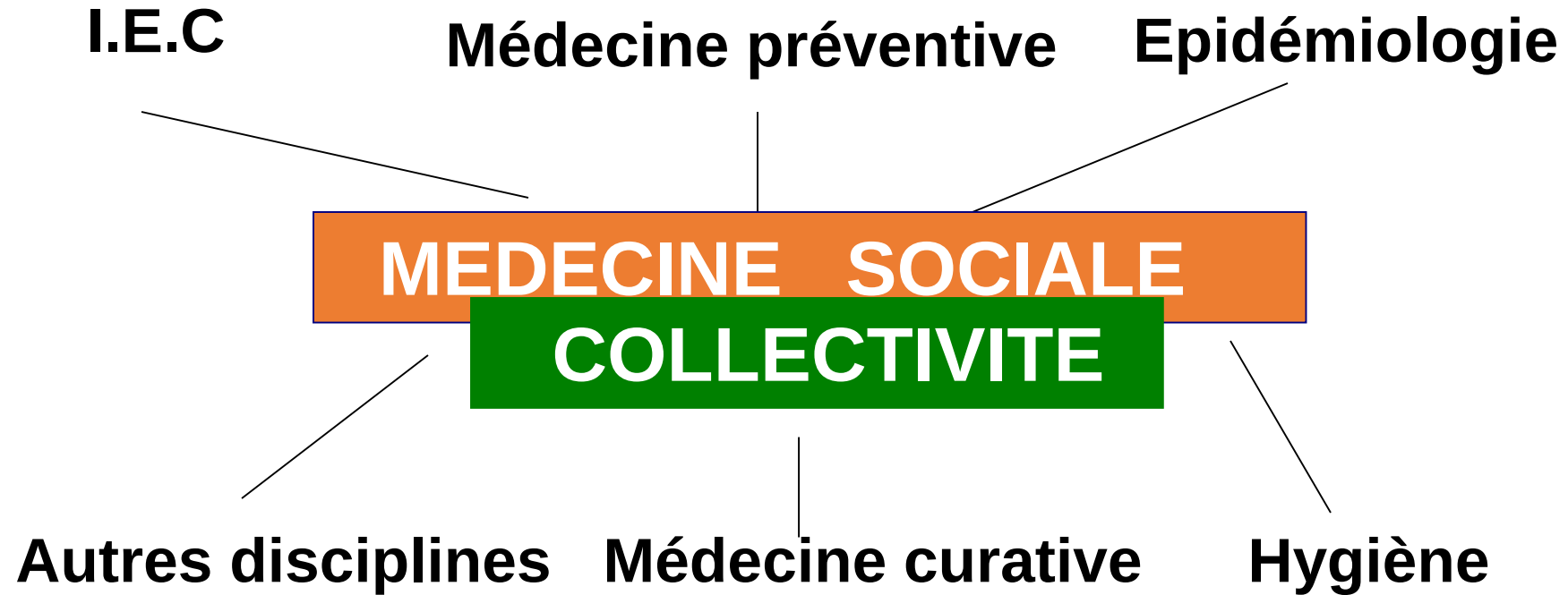
Pr N TACHFOUTI MD, MPH, PhD

Laboratoire d'Epidémiologie et de Recherche en Sciences de Santé

Notions de base

- Approche santé publique/santé communautaire
- Approche santé individuelle
- Médecine sociale:
 - Multidisciplinaire
 - Multisectorielles

Notions de base



Objectifs pédagogiques du module santé publique

- Le module se compose de deux éléments
 - Médecine communautaire
 - Biostatistiques

Objectifs pédagogiques du module santé publique

- Médecine communautaire
 - Comprendre les concepts fondamentaux de santé publique
 - Connaître l'organisation du système de santé au Maroc
 - Connaître les grands problèmes de santé
 - Connaître les principes de base de la prévention
 - Connaître les principes de base de l'épidémiologie
- Biostatistiques
 - Comprendre les principes des biostatistiques
 - Comprendre les principes d'analyse statistique des données de recherche

Objectif général

- Le futur médecin Marocain devra, quelque soit son niveau d'exercice :
 - Contribuer à l'élévation du niveau sanitaire de la population;
 - Jouer un rôle dynamique au sein de la communauté,
 - Favoriser un développement humain durable.

Méthodes utilisées

- Cours magistral illustré de chiffres, figures et tableaux;
- Etude de cas;
- Clarifications à la fin de chaque séance (10mn) : questions-réponses;
- Polycopié/ supports remis à la fin du cours;
- Travaux dirigés

Méthodes utilisées

- L'attention des étudiants est attirée sur le fait que le polycop ne peut constituer, à lui seul, le contenu intégral du cours;
- La présence des étudiants aux cours magistraux est plus que souhaitée

Evaluation

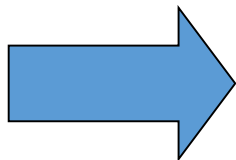
- Le contrôle des connaissances sur l'ensemble du programme se fera par un examen écrit, sous forme de Q.C.M (Questions à Choix Multiples),
- Examen en fin du premier partiel, avec session de rattrapage en fin d'année.

Quelle formation médicale ?

- Profil du médecin attendu pour un système de santé performant?
- Qualité des soins curatifs et préventifs ?
- La réalité du terrain peut « échapper » à l'enseignant lui-même spécialiste et hors contexte communautaire ?
- Comment adapter les régimes des études au vu de l'évolution scientifique d'abord mais aussi démographique, épidémiologique, pédagogique ?

Le modèle du Médecin 5 étoiles de l'OMS

- Le Docteur « cinq étoiles » devrait assumer cinq rôles complémentaires.
 - ✦ Avant tout, bien sûr un rôle de soignant (*care-provider*).
 - ✦ Rôle de décideur (*decision-maker*)
 - ✦ Rôle de communicateur (*communicator*)
 - ✦ Rôle de gestionnaire (*manager*)
 - ✦ Rôle d'animateur de la communauté (*community leader*).



Permanence des relations de confiance
réciproque qui caractérisent le rapport entre
un médecin et son patient.

La médecine, ça n'est pas simplement soigner !

- **La médecine individuelle**
- **La santé publique**
- **La recherche**

I - la santé

-Larousse: Etat de quelqu'un dont l'organisme **fonctionne bien**.

-**absence de maladie** ou d'infirmité (Dictionnaire)

- OMS, 1946 : La santé est un **état de bien être** physique, mental, et social et ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie et d'infirmité.

- Approche positive de la santé (bien être)
- Mais,
 - Définition non opérationnelle car les aspects positifs sont difficilement mesurables
 - La santé n'est mesurée que indirectement à travers la morbidité et la mortalité
- Complet bien être :
 - Composante biologique et autres composantes
 - La notion de santé ou de maladie est perçue différemment en fonction des civilisations et des époques

Autres définitions de la santé

- La santé est l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine (biologique, psychologique et sociale). Cet équilibre nécessite :
 - La satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme (nutritionnels, sanitaires, affectifs et sociaux)
 - Une adaptation sans cesse remise en question de l'homme à un environnement en perpétuelle mutation

Autres définitions de la santé

- Un individu en bonne santé est celui qui est capable de fonctionner aussi efficacement que possible dans son milieu et se consacrer pleinement à ses projets.

La santé Publique

- La santé publique: l'ensemble des problèmes de santé d'une population sous tous ses aspects (curatifs, préventifs, éducatifs et sociaux) ainsi que les services sanitaires qui ont la responsabilité de la santé.

La santé publique

s'intéresse à la santé dans tous ses aspects (préventifs, curatifs et social) ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des services de santé

- Notion de responsabilité croissante des individus et de la communauté devant les risques menaçant la santé
- Notion d'approche multidisciplinaire et multisectorielle

Santé Publique : (définition)

« ...c'est la science et l'art :

- de *prévenir des maladies*,
 - d'*améliorer*, de *prolonger* la vie, la santé et la vitalité mentale et physiques des individus,
- par le **moyen d'une action collective** concertée visant à :
- *assainir le milieu*,
 - *lutter contre les maladies* qui présentent une importance sociale,
 - *éduquer l'individu* (règles d'hygiène, facteurs de risques..)

Santé Publique:(déf Suite)

par le **moyen d'une action collective** concertée visant à :

- *organiser les services médicaux et infirmiers*
 - **pour un diagnostic précoce**
 - **et un traitement préventif des maladies,**
 - *mettre en oeuvre des mesures sociales* propres à
 - **assurer à chaque membre de la collectivité**
- un niveau de vie compatible avec**
- **le maintien de sa santé,**

Santé Publique:(déf. suite)

l'objectif final étant

- ***de permettre à chaque individu***
- ***de jouir de son droit inné***
- ***à la santé et à la longévité. »***

Winslow, 1952

Autre définition de la santé publique

"Alors que, traditionnellement, elle recouvrait essentiellement l'hygiène du milieu et la lutte contre les maladies transmissibles, elle s'est progressivement élargie... On utilise aujourd'hui santé publique au sens large pour évoquer les problèmes concernant la santé d'une population, l'état sanitaire d'une collectivité, les services sanitaires généraux et l'administration des services de soins".

OMS, 1973

Les objectifs de la santé publique

- réduire les décès évitables et ainsi, augmenter l'espérance de vie ;
- réduire les incapacités évitables et ainsi, améliorer la qualité de la vie notamment sans maladie ou incapacité ;
- réduire les inégalités face à la santé.

- Un traité classique de santé publique a donné cette définition :

*« la santé publique est devenu une discipline autonome qui s'occupe de la **santé globale** des **populations** sous tout ses aspects : **curatifs**, **préventifs**, **éducatifs** et **sociaux** ; son objectif est la mise en places de systèmes et d'actions de **promotion** de la santé, de **prévention** et de **traitement** des maladies, de **réadaptation** des handicapés »*

C'est donc une discipline dont l'objectif majeur est de :

- promouvoir
- prévenir
- traiter et réadapter l'état sanitaire de la collectivité.

D'où la nouvelle définition :

*“ La santé publique peut se définir comme la synthèse de toutes les activités spécifiques qui ont pour but de **rétablir, maintenir** ou de **promouvoir** la santé dans une communauté ”.*

La santé publique recouvre la désignation des organismes officiels chargés de

- Organiser le contrôle de l'environnement,
- Appliquer la réglementation sanitaire,
- Planifier et mettre en œuvre les programmes et les actions de santé,
- Evaluer les programmes et les actions de santé (amélioration de l'état de santé),
- Réguler le système de santé.

Ces nouvelles dimensions du concept de santé publique ont deux conséquences pratiques importantes :

1 - Responsabilité croissante des individus, familles et communautés face aux risques qui menacent la santé.

Ex : plusieurs maladies peuvent être prévenu par des mesures simples :

- L'éducation nutritionnelle des mères (malnutrition, diarrhée)
- La vaccination des enfants (rougeole, tétanos néonatale, tuberculose...)
- L'assainissement du milieu.

2 - Approche pluridisciplinaire et multisectorielle des problèmes de santé.

Il existe de nombreux facteurs qui influencent la santé de l'homme, et la maladie est souvent due à un ensemble de causes qui se combinent, interagissent et qui nécessitent donc une action pluridisciplinaire et multisectorielle.

L 'approche multidisciplinaire :

- **L 'épidémiologie:** (identification des problèmes, recherche de leur causes, évaluation des actions entreprises) est une discipline fondamentale en santé publique.
- **La biostatistique** descriptive et analytique

➤ **Les sciences sociales:**

- Analyse les facteurs socio culturelle de la maladie.
- Etudie les attentes d'une population à l'égard des actions de santé.
- Evalue la satisfaction et les relations entre professionnels de santé et usagers.

➤ **L'information**

- La prise de décision.
- Entretient le dialogue social
- La coordination
- Augmente la connaissance

➤ **L'économie**

S'intéresse à des biens des services médicaux, à leur distribution et la formation de leur prix

➤ **L'éducation**

« L'éducation pour la santé, c'est toute combinaison d'expériences, d'apprentissage planifiés destinés à faciliter l'adaptation volontaire de comportement conduisant à la santé »

➤ **La formation**

Les professionnels de santé doivent être liés à la réalités des problèmes de santé des populations et à ceux qui les vivent

➤ **La gestion, management**

recouvrent l'ensemble des mesures prises pour planifier, organiser, faire fonctionner et évaluer la totalité des nombreux éléments interdépendants du système.

➤ **La démographie:**

« c'est une science ayant pour objet l'étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de leur caractères généraux, envisagés principalement d'un point de vue quantitatif »

L'approche multisectorielle

La promotion et la protection de la santé nécessite le regroupement et la coordination des efforts poursuivis dans **les différents secteurs de l'activité humaine** (santé, éducation, agriculture, économie, travaux publics, équipement, Finance, information....)

L'approche en santé publique

- La responsabilité vis à vis de la communauté en opposition à la responsabilité traditionnelle.
- La responsabilité vis à vis de la communauté
 - La promotion de la santé,
 - La prévention,
 - Le diagnostic précoce,
 - La continuité des soins curatifs,

Différences entre l'approche de santé publique et l'approche traditionnelle

	<i>Approche traditionnelle</i>	<i>Approche santé publique</i>
Population concernée	malades	malades et non malades
attitude vis à vis de la population	qui consultent spontanément	même s'ils ne consultent pas
prise en charge	au moment où ils consultent	jusqu'à réinsertion sociale et au contrôle du problème
gestion des ressources	le prix ne compte pas	tient compte des ressources disponibles et mobilisables
Responsabilité de la population	exécuter les prescriptions	décision participative

La santé communautaire

- Les dictionnaires:

" **communauté** " =un groupe dont les membres ont des intérêts communs.

Quelques exemples:

- une association du 3^{ème} âge.
- une association sportive.
- un comité d'intérêt de quartier.
- une association de parents d'élèves.
- un village.

- Ces associations peuvent être:
 - structurées organisées OU
 - informelles mettant en commun les intérêts d'un petit groupe de personnes.
- L'amélioration de la santé par:
 - la participation active ET
 - le développement de la créativité individuelle et collective

La santé communautaire

- Situe l'amélioration de la santé dans une perspective de **développement communautaire**
- Suppose que la communauté **participe** à l'amélioration de sa santé par la mise œuvre une action collective locale.

La santé communautaire: est basée sur

- Une approche des besoins et leur priorisation,
- Une meilleure utilisation de ressources: efficience
- des stratégies adaptées pour améliorer la santé
- accompagné d'un processus d'évaluation continue
- basée sur la concertation et la participation des intéressés.

Se base sur un repérage collectif des problèmes, des besoins et des ressources

→ le diagnostic communautaire

La santé communautaire

fait appel à des intervenants :

- **Les professionnels de santé**
- **Le pouvoir local**
- **Les groupes de population**
- **Les agents de développement (médiateurs)**

Les intervenants de santé communautaire

- **Les professionnels de santé**
 - Leur rôle dépasse celui d'être une " ressource " pour les actes de diagnostic et de thérapie exercés à la demande de l'individu malade.
 - ils sont associés à la réflexion, mais leur expertise est une contribution et non une solution unique
- **Le pouvoir local**
- **Les groupes de population**
- **Les agents de développement**

Les intervenants de santé communautaire

- **Les professionnels de santé**
- **Le pouvoir local**
 - leurs choix et leur soutien à la santé communautaire est un élément déterminant de son implantation et de son développement.
- **Les groupes de population**
- **Les agents de développement**

Les intervenants de santé communautaire

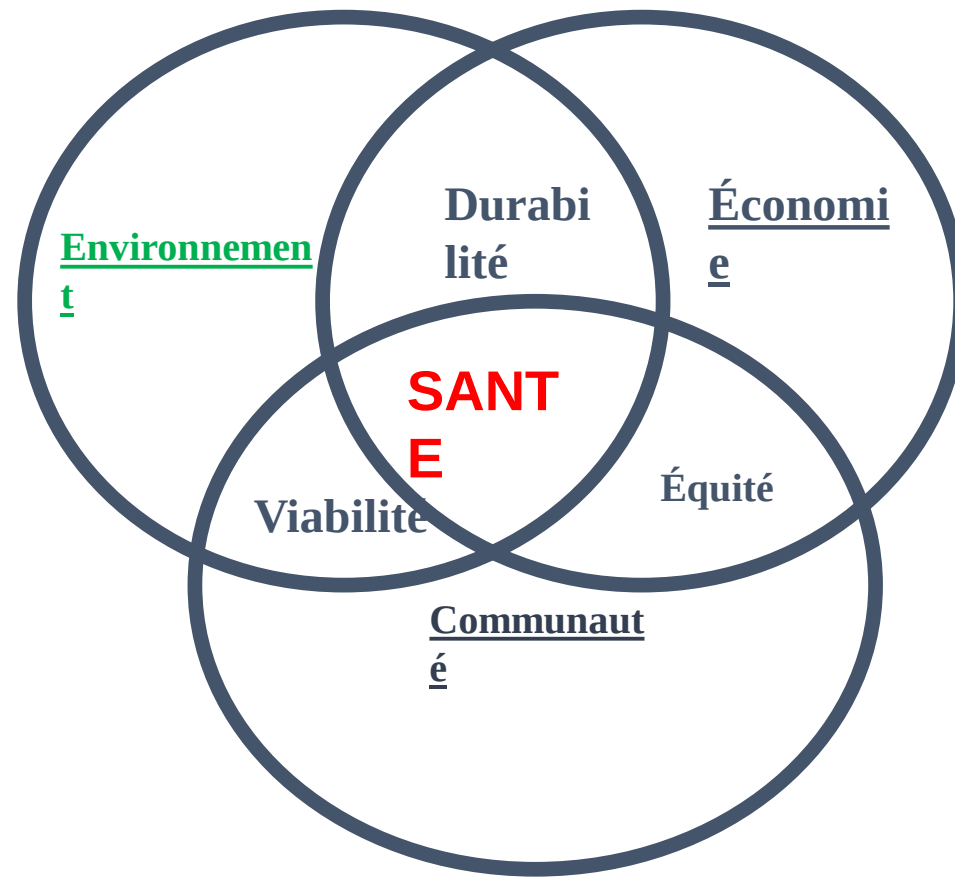
- **Les professionnels de santé**
- **Les pouvoirs locaux**
- **Les groupes de population**
 - Si un niveau n'est pas impliqué, on ne pourra pas mettre en œuvre des actions efficaces.
 - Le processus de " mieux connaître pour mieux choisir et agir" nécessite l'engagement des trois catégories.
- **Les agents de développement**

Les intervenants de santé communautaire

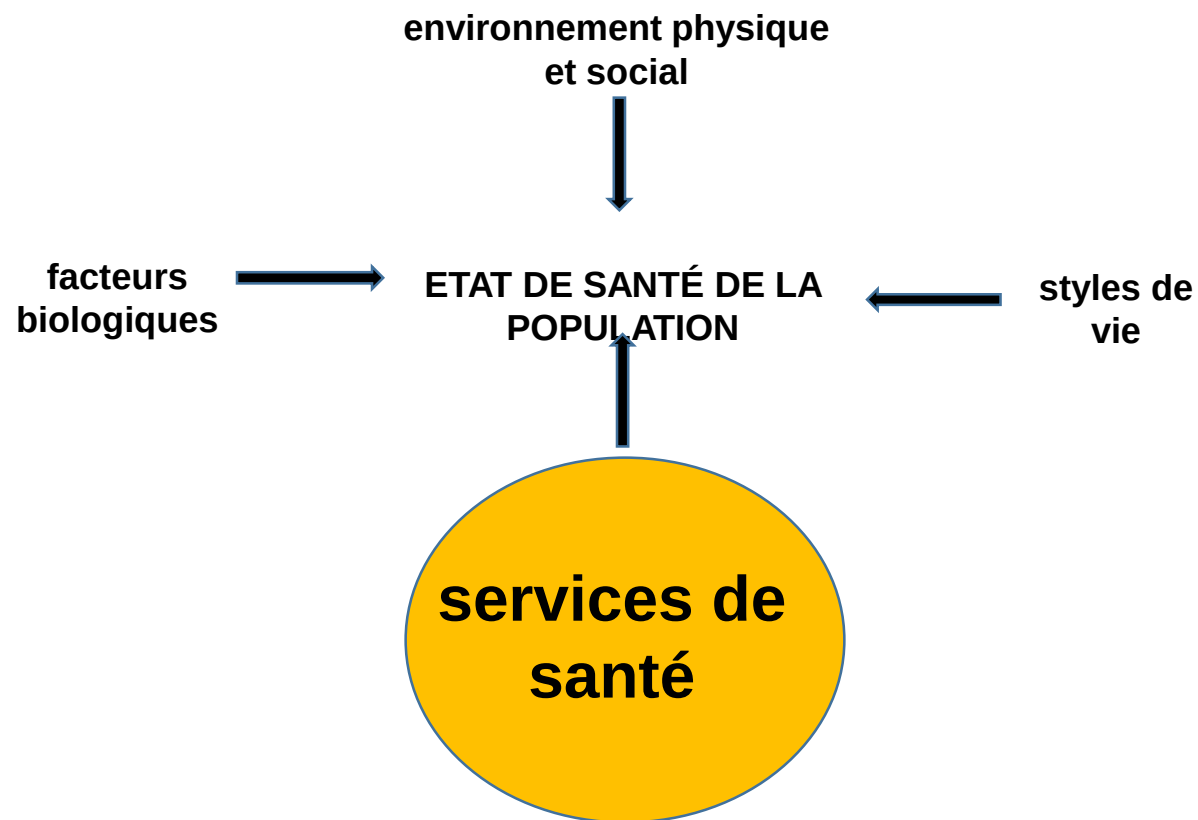
- Les professionnels de santé
- Les pouvoirs locaux
- **Les groupes de population**
- **Les agents de développement**
 - Ou les médiateurs : peuvent impulser des projets, faire le lien entre population et administration, faciliter les démarches... ;
 - Ils aident à l'autonomisation du groupe

Conclusion

L'approche collective de la santé a pour but d'assurer à **chaque membre** de la collectivité, un niveau de vie compatible avec la **conservation** et la **promotion** de la santé et **d'améliorer le bien-être** des individus par le moyen **d'action concertées** visant à assainir le milieu, lutter contre les fléaux sociaux, enseigner les règles d'hygiène, organiser les services sanitaires en vue de la **prévention**, du **dépistage**, du **traitement** et de la **réadaptation**, etc. ...



Déterminants de l'état de santé



Questions

- Comment faire diminuer la gravité de la pandémie Covid 19 ?
 - Dans le monde, au Maroc
- Comment faire diminuer la mortalité maternelle ?
 - Dans le monde, au Maroc
- Comment faire baisser la prévalence du diabète ?

Questions

- Comment prendre en charge tous les malades atteints de cancer au Maroc ?
- Comment prendre en charge tous les malades atteints d'hépatites C au Maroc ?
- Est-il possible de vacciner toute la population ?

Questions

- Le nombre d'hôpitaux, est-il suffisant ?
- Le nombre de médecins, est-il suffisant ?
- Le nombre de personnels paramédical est-il suffisant ?
- Comment améliorer la motivation de la RH ?

Questions

- Le budget du MS, est-il suffisant ?
- L'assurance maladie ?
- La recherche médicale est-elle développée ?
- L'industrie pharmaceutique ,
- Le prix du médicament ?
- Le conseil de l'ordre.

Situations liées aux systèmes de santé

Problématique

- Les urgences du CHU de Fès reçoivent trop de patients par rapport aux autres hôpitaux de la ville



- Pourquoi ?

Un enfant de deux ans a de la fièvre et des convulsions. Sa mère le conduit à l'hôpital le plus proche, distant de 30 kilomètres

on lui annonce que le stock de médicaments nécessaires pour traiter l'infection est épuisé.



- Quel serait son évolution??

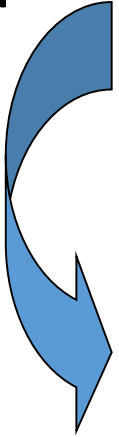
Un ouvrier doit être opéré. Pour payer l'intervention, qui lui sauvera la vie, la famille dépense toutes ses économies,



La famille se retrouve alors dans l'impossibilité de régler le loyer et perd son logement.

Une infirmière, surmenée du fait des mauvaises conditions de travail et du manque d'effectifs dans l'hôpital où elle travaillait et incapable de subvenir aux besoins des nombreuses personnes à sa charge,

émigre pour trouver un emploi mieux rémunéré.



- Quel est l'impact sur la disponibilité des ressources humaines??

Une femme accouche après trois jours d'attente, seule sa belle-sœur est à ses côtés. L'enfant est mort-né et la mère garde de graves séquelles – une fistule obstétricale

Un système de santé mal organisé et disposant de ressources insuffisantes ne rend souvent pas service aux personnes qui en dépendent

un système de santé qui fonctionne bien améliore la qualité de vie de la population.



Médecine
universelle

Mais,

**Environnement
épidémiologique
socio-économique**

I - Définition et missions d'un système de santé

Système de santé: terme utilisé de façon informelle pour

- Désigner le régime de fourniture de soins de santé dans une société
 - préventif
 - curatif
- qu'ils soient organisés en un système cohérent ou non

Définition:

« L'ensemble des **ressources** humaines, matérielles et financières ainsi que les **institutions** et les **activités** destinées à assurer la promotion, la protection, la restauration et la réhabilitation de la santé de la population »

- Définition de l'OMS (2000)

«Un système de santé inclut toutes les activités dont le but essentiel est de **promouvoir, restaurer ou entretenir la santé.**»

I - Définition et missions d'un système de santé

« Toutes les **activités** officielles ou non qui portent sur les services de santé mis à la disposition d'une population donnée et sur l'**utilisation** de ces services par la population »

OMS, 1971

Missions d'un système de santé

- Prévention
- Promotion de la santé
- Distribution des soins : ambulatoires, cliniques essentiels, soins tertiaires

Composantes d'un système de santé

- Un système de santé performant fournit des prestations de qualité à tous, quel que soit le moment et le lieu où ils en ont besoin.
- La disposition exacte des services varie d'un pays à l'autre, mais comporte six éléments.

Composantes d'un système de santé

- Ressources humaines
 - Personnels suffisant et qualifié
- Ressources financière
 - Budget et assurances maladie
- Recherche scientifique
- Système d'information
 - Des données fiables sur lesquelles fonder des décisions et politiques

Composantes d'un système de santé

- Prestation des services : offre / demande de soins
Secteur public et Secteur privé
 - Demande : patients / population
- Structure organisationnelle
 - Administration
 - Systèmes d'approvisionnement
 - une infrastructure bien entretenue
 - Des moyens logistiques pour acheminer des médicaments et des technologies de qualité.....

Caractéristiques d'un système de santé

- Globalité
 - Disponibilité
 - Accessibilité
 - Acceptabilité
 - Qualité
- 1. Planifiable et évaluable**
 - 2. Souple et modifiable**

Globalité

- Un système globale doit permettre une prise en charge globale des usagers
 - soins curatifs
 - préventifs,
 - rééducation,
 - réadaptation
 - promotion de la santé

Disponibilité

- **Disponibilité**

- Il doit exister suffisamment d'installations, de biens et de services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé.

Accessibilité

- **Accessibilité**

- Les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles
 - non-discrimination
 - accessibilité physique
 - accessibilité économique
 - accessibilité de l'information



Equité

Acceptabilité

- **Acceptabilité**

- Les installations, biens et services en matière de santé doivent être:
 - Respectueux de l'éthique médicale,
 - Appropriés sur le plan culturel
 - Réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et aux différents stades de la vie.

Qualité

- **Qualité**

- Les installations, biens et services en matière de santé doivent être:
 - Respectueux de l'éthique médicale,
 - Appropriés sur le plan culturel
 - Réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et aux différents stades de la vie.

Souplesse

- Un système doit pouvoir s'adapter à toute situation nouvelle exigée par
 - le type et la fréquence de morbidité,
 - le progrès technologique et
 - les conditions socio-économiques.

Evaluable et planifiable

- Le système doit permettre d'identifier les ressources disponibles pour satisfaire les besoins et choisir les solutions capables de modifier la situation
- Il convient ensuite d'évaluer le degré d'atteinte des objectifs selon les moyens et les ressources mobilisés

II – Définition d'un programme de santé

- Pourquoi un programme sanitaire ?
 - Lutter contre un problème de santé publique
 - la lutte doit être :
 - Standardisée (formation et guides)
 - Efficace et efficiente.

Définition d'un programme de santé

- Ensemble organisé, cohérent et intégré d'activités et de services réalisés simultanément ou successivement avec les ressources nécessaires dans le but d'atteindre des objectifs déterminés en rapport avec des problèmes de santé précis et ce pour une population définie

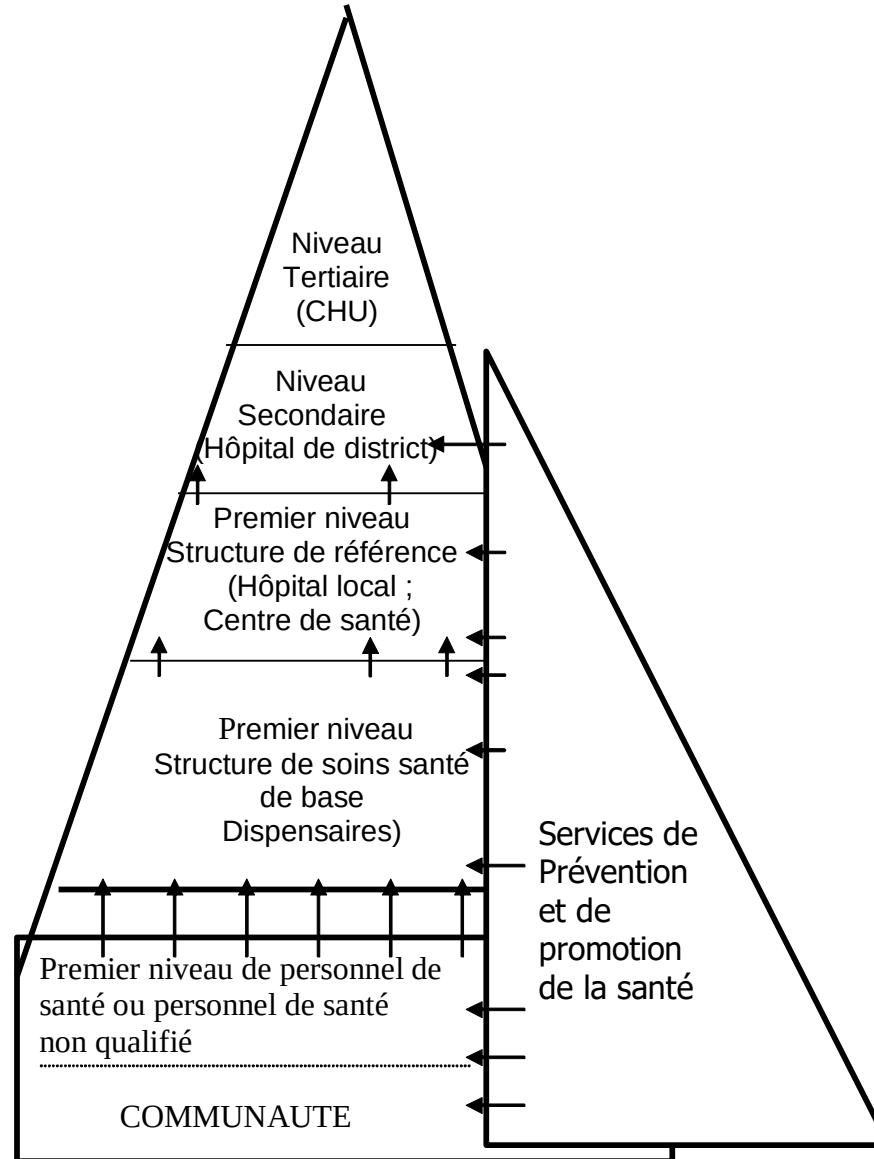
Pourquoi un programme de santé

- Lutter contre un **problème de santé publique**
- la lutte doit être :
 - **Standardisée** (formation et guides)
 - **Efficace et efficiente.**

Qu'est-ce qu'un système de santé idéal ?

- Le système de santé idéal doit être :
 - Global, c'est-à-dire qui ne néglige aucun secteur ou objectif (prévention, soins très spécialisés)
 - Accessible, géographiquement (proximité) et économiquement (coût acceptable)
 - Efficace, techniquement et économiquement
 - Acceptable, c'est-à-dire qui a l'accord de la population (par exemple pour les fermetures de maternités)
 - Planifiable et évaluable, c'est-à-dire qu'on peut prévoir et mesurer (via des indicateurs de santé)
 - Souple et modifiable (adaptable à des circonstances particulières. Ex : épidémie, catastrophe...)

Structure et organisation en “voilier” des services de santé



Modèles pour le système de santé

- Les systèmes de santé ont une histoire relativement récente mais très progressive. De 1880 à nos jours :
 - 1880-1890 : les assurances sociales obligatoires en Allemagne
 - 1930-1940 : l'assurance chômage et vieillesse aux USA
 - 1945-50 : les assurances sociales obligatoires en France
 - 1965-70 : l'assurance maladie aux USA (pour certaines populations)
 - 2000 : la Couverture Maladie Universelle en France
 - 2007 : la Couverture Maladie Universelle en Allemagne
 - 2008-2009 : débat sur la couverture maladie aux USA
 - 2009 : Démarrage de l'AMO au Maroc

L'Allemagne

Le cas de l'Allemagne: Bismackien ou assurantiel

- Système Bismarckien : qui travaille est assuré
 - Allemagne: le 1er pays de l'UE à mettre une réforme visant à maîtriser les dépenses de santé
- La technique de l'assurance repose sur 3 principes :
 - Son caractère obligatoire
 - Un niveau de contribution proportionnel au salaire et non au risque
 - Une charge financière répartie entre les assurés et employeurs avec possibilité de subventions de l'État

Les modèles Beverdgiens

- Lord Beveridge, père fondateur du système britannique,
- **Gestion par l'État et financement par l'impôt.**
- Principes d'universalité et d'égalité,
 - Accès gratuit
 - aux services de soins pour les résidents,
 - des hôpitaux publics et des professionnels de santé pour la plupart des fonctionnaires salariés.

Fonctionnement du système de santé britannique

- La couverture maladie est universelle.
 - Les soins sont gratuits pour toute personne en exprimant le besoin ou la nécessité.
- une participation financière forfaitaire du patient
- Le malade a un choix limité
 - attente longue pour toute consultation spécialisée ou intervention non urgente

Le système mixte

- Les régimes mixtes d'Europe du Sud sont marqués par la combinaison d'éléments divers, inspirés des différents systèmes :
- mélange dans le financement d'impôts et de cotisations, d'organismes publics et privés ou d'assurances sociales et de services de santé directement fournis par l'État

Les régimes libéraux

Les Etats-Unis

Les régimes libéraux

- Absence d'une protection sociale publique universelle et obligatoire financée par la solidarité.
- Le système de soins repose sur l'assurance privée, même si des programmes publics d'assurance existent pour certaines catégories
- Il n'y a pas de financement public généralisé.
- Caractéristique: liberté de l'offre et demande.